OPOSICIÓN UTRERA | TÉCNICO/A MEDIO EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | MATERIAS ESPECÍFICAS · TEMA 34

Tema 34: Las drogas. Legislación básica. Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. La prevención de la drogodependencia. Los centros provinciales de drogodependencias

Ámbito: Drogodependencias, Adicciones, Marco Jurídico, Red Asistencial y Prevención Socioeducativa Municipal

Tema 34 — Las drogas. Legislación básica. Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. La prevención de la drogodependencia. Los centros provinciales de drogodependencias

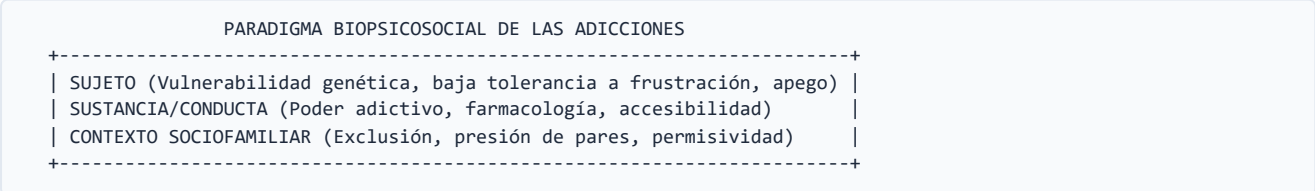
Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Oferta de Empleo Público consolidada (BOP de Sevilla nº 102, de 29/05/2026).
Bloque: Materias Específicas. Ámbito: Drogodependencias, Adicciones, Marco Jurídico e Intervención Socioeducativa Municipal.

1. Introducción y Justificación Epistemológica y Socioeducativa

El consumo problemático de sustancias psicoactivas y la emergencia de las adicciones comportamentales o sin sustancia (juego patológico, apuestas online, uso compulsivo de tecnologías) constituyen uno de los fenómenos psicosociales más complejos, dinámicos y lesivos para la salud pública y la cohesión social contemporánea. Lejos de constituir un problema meramente individual, moral o biomédico, la adicción es una enfermedad crónica, recurrente y biopsicosocial determinada por la confluencia multifactorial de variables biológicas, psicológicas, familiares, económicas y socioculturales.

En el marco competencial de la **Administración Local**, los artículos 25.2.e y 26.1.c de la **Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)**, en concordancia con el artículo 9.1.a de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)** y la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**, atribuyen a los municipios de más de 20.000 habitantes competencias propias indispensables en materia de promoción de la salud, prevención comunitaria de drogodependencias, detección precoz e inserción social de personas afectadas.

Para el Educador y la Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, integrados en los Equipos de Servicios Sociales Comunitarios y en dispositivos especializados, la intervención socioeducativa en drogodependencias no se limita a la mera transmisión informativa sobre los riesgos toxicológicos. Su labor técnica abarca la dinamización comunitaria en barrios desfavorecidos, el fomento de factores de protección familiar, el acompañamiento socioeducativo a personas en tratamiento ambulatorio o en régimen de reducción de daños, y la mediación e inserción sociolaboral a través de programas especializados como el programa **Arquímedes**, garantizando una atención universal, pública, gratuita y libre de estigmas.

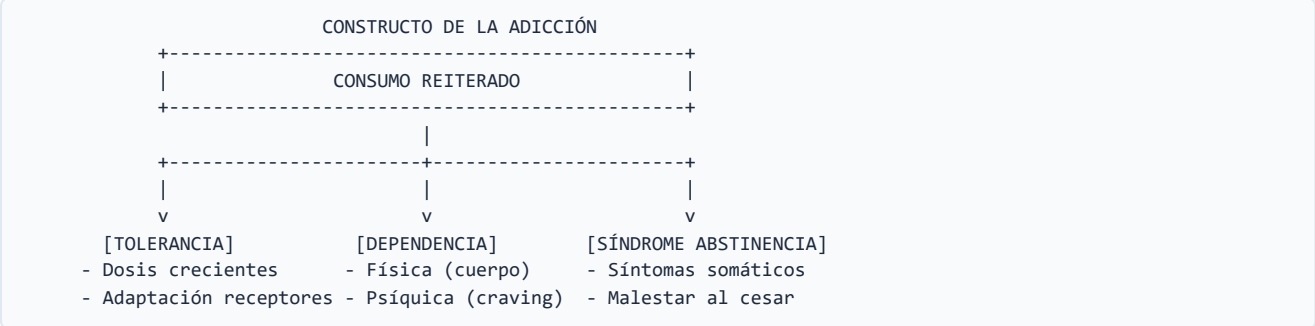


2. Las Drogas: Concepto, Neurobiología y Clasificaciones

2.1. Concepto Científico y Términos Diagnósticos Clave

La **Organización Mundial de la Salud (OMS)** define como **droga** toda sustancia que, introducida en el organismo vivo por cualquier vía de administración (inhalada, fumada, oral, intravenosa, intramuscular o transdérmica), produce una alteración de algún modo en el funcionamiento natural del **Sistema Nervioso Central (SNC)** del individuo y es susceptible de crear **dependencia** (física, psicológica o ambas), así como **tolerancia**.

En el estudio riguroso de las drogodependencias y adicciones, es imperativo dominar los siguientes constructos clínicos: 1. **Dependencia Física**: Estado de adaptación biológica del organismo caracterizado por la necesidad imperiosa de mantener niveles plasmáticos determinados de la sustancia para funcionar con aparente normalidad. Su manifestación inequívoca es la aparición del **síndrome de abstinencia** cuando se interrumpe o reduce bruscamente el consumo. 2. **Dependencia Psicológica o Psíquica**: Compulsión, anhelo o deseo irrefrenable (**craving**) de consumir periódica o continuamente la sustancia para experimentar un estado de placer, euforia o para evitar un malestar psicológico (ansiedad, anomia, vacío existencial). Es la dimensión más compleja y duradera de la adicción, persistiendo mucho tiempo después de haberse superado la desintoxicación física. 3. **Tolerancia**: Fenómeno psicobiológico por el cual el organismo se adapta a la presencia continuada de la sustancia, requiriéndose **dosis progresivamente mayores** para obtener los mismos efectos placenteros que inicialmente se lograban con dosis menores, o bien la disminución notable del efecto con el uso continuado de la misma dosis. Se divide en: - *Tolerancia metabólica o farmacocinética*: Aumento de la capacidad enzimática del hígado para metabolizar y eliminar la droga con mayor rapidez. - *Tolerancia celular o farmacodinámica*: Adaptación de los receptores neuronales del SNC, que reducen su sensibilidad (*down-regulation*). - *Tolerancia cruzada*: Fenómeno por el cual el desarrollo de tolerancia hacia una droga produce tolerancia automática hacia otras drogas farmacológicamente afines (ej.: alcohol y benzodiacepinas). 4. **Síndrome de Abstinencia**: Conjunto de signos y síntomas físicos y psíquicos de naturaleza desagradable y potencialmente letal que se desencadenan cuando una persona con dependencia física suspende o reduce bruscamente la ingesta de la droga. Su cuadro más extremo en el consumo crónico de alcohol es el **Delirium Tremens** (emergencia médica con temblores, hipertermia, alucinaciones microzoópsicas y convulsiones).



2.2. Neurobiología de la Adicción: El Circuito de Recompensa Cerebral

Los avances en neurociencia han demostrado que todas las drogas de abuso, independientemente de sus efectos clínicos diferenciados, comparten un mecanismo neurobiológico común: la hiperestimulación artificial del **sistema mesocorticolímbico de recompensa cerebral**.

1. **Estructuras Anatómicas Involucradas**:
2. **Área Tegmental Ventral (ATV)**: Núcleo del mesencéfalo donde se originan las neuronas dopaminérgicas.
3. **Núcleo Accumbens (NAcc)**: Centro subcortical del estriado ventral que actúa como la estación de relevo fundamental del placer, la motivación y el refuerzo positivo.

4. **Amígdala y Corteza Prefrontal (CPF)**: Regulan la memoria emocional de la experiencia, el juicio moral, la toma de decisiones y el control inhibitorio de los impulsos.
5. **El Papel de la Dopamina**: En situaciones naturales (alimentación, afecto, juego, reproducción), el cerebro libera cantidades fisiológicas de dopamina para reforzar conductas adaptativas de supervivencia. Las drogas secuestran este sistema, provocando una liberación masiva e inundante de dopamina en el núcleo accumbens (hasta diez veces superior a los estímulos naturales).
6. **Neuroadaptación y Pérdida de Control**: Con el consumo crónico se produce una atrofia y reducción de los receptores dopaminérgicos D2 en el cuerpo estriado y una desconexión funcional de la corteza prefrontal ventromedial y dorsolateral. El cerebro pierde la capacidad de experimentar placer con los estímulos cotidianos (**anhedonia**) y se produce el colapso del control voluntario reflexivo, consolidando el patrón adictivo compulsivo.

2.3. Clasificaciones Científicas de las Drogas

Doctrinalmente existen diversas clasificaciones según su régimen jurídico (legales e ilegales), su origen (naturales, semisintéticas y sintéticas) o su peligrosidad social. Sin embargo, la clasificación taxonómica de mayor relevancia científica y médica es la basada en los **efectos producidos sobre el Sistema Nervioso Central**, formulada originariamente por Robert Kramer y Cameron (1975) y universalmente asumida por la OMS:

CLASIFICACIÓN SEGÚN EFECTOS EN EL SNC

CATEGORÍA	DENOMINACIÓN CLÍNICA	SUSTANCIAS PRINCIPALES
1. DEPRESORAS	Psicolépticos (Adormecen el SNC)	Alcohol, Opiáceos, Benzodiacepinas, Ghb.
2. ESTIMULANTES	Psicoanalépticos (Aceleran el SNC)	Cocaína, Anfetaminas, Metanfetamina, Nicotina.
3. PERTURBADORAS / ALUCINÓGENAS	Psicodislépticos (Distorsionan el SNC)	Cannabis, LSD, Éxtasis (MDMA), Ketamina, 2C-B.

2.3.1. Drogas Depresoras del SNC (Psicolépticos)

Sustancias que amortiguan, ralentizan o inhiben el funcionamiento fisiológico del cerebro. Producen sedación, relajación muscular, enlentecimiento motor y cognitivo, somnolencia y, en dosis elevadas, coma y paro cardiorrespiratorio. - **Alcohol (Etanol)**: La droga institucionalizada de mayor prevalencia y coste sociosanitario. Depresor gabaérgico que genera desinhibición inicial transitoria y posterior sedación. - **Opiáceos y Opioides**: - *Naturales*: Morfina, codeína. - *Semisintéticos*: Heroína (diacetilmorfina, de altísimo potencial adictivo por vía parenteral o fumada). - *Sintéticos*: Metadona (agonista puro de larga duración utilizado en programas de sustitución), buprenorfina, fentanilo (potente analgésico opioide sintético responsable de graves epidemias de sobredosis en Norteamérica). - **Hipnóticos y Sedantes**: Benzodiacepinas (diazepam, lorazepam) y barbitúricos. Elevadísima prescripción médica y alto riesgo de tolerancia cruzada con el alcohol. - **Disolventes e Inhalantes Volátiles**: Colas, pegamentos, pinturas (inhalación de hidrocarburos con grave toxicidad neurológica y hepática).

2.3.2. Drogas Estimulantes del SNC (Psicoanalépticos)

Sustancias que aceleran el funcionamiento del sistema nervioso central, induciendo euforia, hiperactividad motriz, alerta sensorial, taquicardia, insomnio y supresión del apetito y la fatiga. - **Estimulantes Mayores**: - *Cocaína* (Clorhidrato de cocaína esnifado o inyectado; y su base libre fumable, conocida como *crack* o pasta base, de absorción pulmonar fulminante y brutal poder adictivo). - *Anfetaminas y derivados*: Speed (sulfato de anfetamina), metanfetamina (*cristal meth*), metilfenidato. - **Estimulantes Menores**: - *Nicotina*: Alcaloide

presente en el tabaco y en dispositivos de vapeo electrónico; posee un índice de adicción física comparable o superior a la heroína. - *Xantinas*: Cafeína, teobromina, teofilina (bebidas energéticas y café).

2.3.3. Drogas Perturbadoras del SNC o Alucinógenas (Psicodislépticos)

Sustancias que alteran cualitativamente el funcionamiento cerebral, distorsionando la percepción sensorial (alucinaciones visuales y auditivas), la vivencia del tiempo y del espacio y el juicio crítico de la realidad. - **Derivados del Cannabis**: Hachís, marihuana, aceite de hachís (principio activo psicoactivo primario: **Delta-9-Tetrahidrocannabinol o THC**; y principio no psicoactivo con potencial ansiolítico: **Cannabidiol o CBD**). Es la droga ilegal más consumida en España y Europa, con grave impacto en la maduración de la corteza prefrontal adolescente (amotivación, fracaso escolar y desencadenamiento de brotes psicóticos). - **Alucinógenos Clásicos**: LSD (dietilamida del ácido lisérgico), mescalina (del peyote), psilocibina (de hongos alucinógenos). - **Drogas de Síntesis y Entactógenos**: MDMA (éxtasis: mezcla propiedades estimulantes y perturbadoras de empatía emocional), MDA, metilona. - **Anestésicos Disociativos**: Ketamina (*special K*), fenciclidina (PCP o polvo de ángel). - **Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)**: Cannabinoides sintéticos (*Spice*), catinonas sintéticas (*sales de baño*), derivados de feniletilamina (2C-B o *tucibi*).

2.4. Adicciones Comportamentales o sin Sustancia

En las dos últimas décadas, el concepto de adicción se ha ampliado formalmente para acoger las **adicciones conductuales**, que comparten los mismos sustratos neurobiológicos de recompensa y pautas clínicas (pérdida de control, craving, tolerancia, abstinencia e interferencia grave en la vida familiar y laboral) sin mediación de sustancias químicas: * **Juego Patológico o Ludopatía**: Primera adicción sin sustancia reconocida formalmente como trastorno adictivo en el **DSM-5** (2013). Incluye el juego presencial tradicional (máquinas tragaperras, casinos) y la modalidad de mayor impacto juvenil: **las apuestas deportivas online y salones de juego presenciales**. * **Trastorno por Uso de Videojuegos (*Gaming Disorder*)**: Incorporado oficialmente en la **CIE-11** de la OMS (2018), caracterizado por el uso descontrolado de videojuegos con prioridad destructiva sobre las demás actividades vitales. * **Uso Problemático de Internet, Redes Sociales y Dispositivos Móviles**: Problemática sociocomunitaria que afecta prioritariamente a la infancia y adolescencia, generando aislamiento social, alteraciones del sueño y ciberacoso.

---

3. Legislación Básica en Materia de Drogodependencias y Adicciones

El ordenamiento jurídico aplicable a las adicciones articula normas internacionales, estatales y autonómicas que regulan el control de sustancias, el régimen penal y de seguridad ciudadana, las limitaciones a la publicidad y venta, y las garantías de asistencia sociosanitaria.

```
                    PIRÁMIDE JURÍDICA DE LAS ADICCIONES
=========================================================================
INTERNACIONAL : Convenios de la ONU de 1961, 1971 y 1988 | UE Drogas.
-------------------------------------------------------------------------
ESTATAL       : * Ley 17/1967 (Estupefacientes) | Ley 17/2003 (Decomisos).
              : * Ley 28/2005 y Ley 42/2010 (Medidas Tabaquismo).
              : * Ley Orgánica 4/2015 (Seguridad Ciudadana, arts. 36.16-18).
              : * Código Penal (arts. 368-378 Salud Pública; art. 80.5 y 87 CP).
              : * Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024.
-------------------------------------------------------------------------
AUTONÓMICA    : * Ley 4/1997, de 9 de julio (Prevención/Asistencia Andalucía).
ANDALUZA      : * Decreto 273/2001 (Acreditación de Centros).
              : * Decreto 70/2004 (Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones).
              : * Ley 9/2016 (Servicios Sociales de Andalucía).
=========================================================================
```

3.1. Marco Internacional y de la Unión Europea

- **Convenios de las Naciones Unidas**:

- *Convención Única sobre Estupefacientes de 1961* (enmendada por el Protocolo de 1972): Fiscalización internacional de opiáceos, cocaína y cannabis.
- *Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971*: Control de alucinógenos, anfetaminas, barbitúricos y sedantes.
- *Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988*: Lucha penal contra el narcotráfico y blanqueo de capitales.
- **Estrategia de la Unión Europea sobre Drogas (2021-2025)**: Documento marco comunitario que pivota sobre tres ejes: reducción de la oferta, reducción de la demanda y tratamiento de los daños colaterales.

3.2. Marco Normativo Estatal

1. **Ley 17/1967, de 8 de abril**, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y se adaptan a lo establecido en el Convenio de 1961.
2. **Ley 28/2005, de 26 de diciembre**, de medidas sanitarias frente al tabaquismo (modificada por la **Ley 42/2010, de 30 de diciembre**): Establece la prohibición total de fumar en todos los espacios cerrados de uso público y lugares de trabajo, así como en recintos educativos y sanitarios.
3. **Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana**:
4. *Artículo 36.16*: Tipifica como **infracción grave** el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de instrumentos para su consumo.
5. *Disposición Final Quinta*: Posibilidad de **suspensión de la sanción económica a menores de edad** si se someten voluntariamente a actividades de reeducación o tratamiento de deshabituación en centros acreditados.
6. **Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)**:
7. *Delitos contra la Salud Pública (artículos 368 a 378)*: Sanciona el cultivo, elaboración, tráfico o posesión ilícita preordenada al tráfico. El art. 368 distingue entre:
   - Sustancias que **causan grave daño a la salud** (heroína, cocaína, anfetaminas, MDMA, LSD): penas de 3 a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo.
   - Sustancias que **no causan grave daño a la salud** (cannabis, derivados, hachís): penas de 1 a 3 años de prisión y multa del tanto al duplo.
8. *Beneficio de Suspensión de la Pena por Deshabituación (artículo 80.5 y artículo 87 CP)*: Permite al juez suspender penas de prisión de **hasta 5 años** (en lugar del límite general de 2 años) a delincuentes que hayan cometido el delito a causa de su dependencia a las drogas, siempre que se acredite el tratamiento de deshabituación o su conclusión con éxito.
9. **Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas (Ley 17/2003, de 29 de mayo)**: Los recursos económicos y bienes incautados al narcotráfico se adscriben al Plan Nacional sobre Drogas para financiar programas de prevención, tratamiento e inserción social en comunidades autónomas y corporaciones locales.
10. **Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024**: Documento de consenso intersectorial que aborda de forma unificada tanto las drogas ilegales y legales (alcohol, tabaco, psicofármacos) como las adicciones comportamentales (juego patológico, pantallas).

3.3. Marco Normativo Autonómico en Andalucía

1. **Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de Andalucía**:
2. Constituye la **ley matriz andaluza** en la materia.

3. Prohíbe taxativamente la venta, suministro y dispensación de cualquier tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de 18 años (art. 16 y 25).
4. Regula las limitaciones de la publicidad de alcohol y tabaco en medios de comunicación y en la vía pública (prohibición a menos de 200 metros de centros educativos).
5. Tipifica el régimen sancionador andaluz (infracciones leves, graves y muy graves).
6. **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**, sobre acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones en Andalucía: Fija los requisitos materiales, funcionales y de personal para autorizar el funcionamiento de centros ambulatorios, residenciales y de reducción del daño.
7. **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**, por el que se regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: Establece la estructura institucional de planificación y coordinación intersectorial en la Junta de Andalucía.

---

4. El Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA)

El **Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA)** es el instrumento directivo y vertebrador de todas las políticas públicas que la Junta de Andalucía despliega en materia de adicciones.

```
                    EJES ESTRATÉGICOS DEL PADA
=========================================================================
EJE 1: PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL:
* Prevención comunitaria, familiar y escolar (retraso inicio de consumos).
* Inserción formativo-laboral (Programa Arquímedes y Red de Artesanos).
-------------------------------------------------------------------------
EJE 2: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA Y REDUCCIÓN DE DAÑOS:
* Desintoxicación (ambulatoria y hospitalaria en UDH).
* Deshabituación y rehabilitación biopsicosocial (CTA, CT, VAT).
* Reducción del daño (metadona, intercambio jeringuillas, CEA).
-------------------------------------------------------------------------
EJE 3: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN:
* Sistema de Información del PADA (SIPADA).
* Formación de profesionales y observatorio epidemiológico andaluz.
=========================================================================
```

4.1. Adscripción Institucional y Evolución

Originalmente adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales y posteriormente a la de Igualdad y Políticas Sociales, en la estructura orgánica actual de la Junta de Andalucía las competencias en materia de adicciones corresponden a la **Consejería de Salud y Consumo**, incardinadas en la **Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica** a través del correspondiente **Servicio de Adicciones**.

4.2. Principios Rectores del Plan Andaluz

- **Integralidad y Modelo Biopsicosocial**: La persona adicta es atendida en su totalidad psicofísica y en su red relacional y familiar.
- **Acceso Público, Universal y Gratuito**: Toda la red asistencial andaluza de adicciones forma parte del sistema sanitario y social público sin copago alguno.
- **Proximidad y Descentralización**: Garantizar recursos de tratamiento ambulatorio cercanos al ciudadano en las cabeceras de comarca y municipios.
- **Transversalidad y Perspectiva de Género**: Abordaje específico de la doble estigmatización que sufren las mujeres con problemas de adicciones (frecuentes víctimas de violencia de género, miedo a la pérdida de custodia de sus hijos y necesidad de recursos con plazas adaptadas para madres con menores).
- **Intersectorialidad**: Coordinación estrecha entre Servicios Sociales, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Educación, Empleo, Justicia e Instituciones Penitenciarias.

---

5. La Prevención de la Drogodependencia

La prevención en drogodependencias comprende el conjunto de medidas y estrategias socioeducativas dirigidas a evitar la aparición del consumo, retrasar la edad de inicio, atenuar los consumos problemáticos y reducir las consecuencias lesivas asociadas al uso de sustancias o conductas adictivas.

5.1. Niveles de Prevención según Gordon (1987) y la OMS

En la doctrina moderna sobre adicciones se ha superado la clasificación médica tradicional (primaria, secundaria, terciaria) en favor de la tipología operativa formulada por **Robert Gordon (1987)**, asumida por la Estrategia Nacional y el PADA:

```
                NIVELES DE PREVENCIÓN DE ROBERT GORDON
========================================================================
1. PREVENCIÓN UNIVERSAL:
   * Destinatarios: Toda la población diana sin distinción de riesgo.
   * Ámbito: Escuelas, familias y comunidad general.
   * Meta: Fomentar factores de protección y retrasar la edad de contacto.
------------------------------------------------------------------------
2. PREVENCIÓN SELECTIVA:
   * Destinatarios: Subgrupos vulnerables expuestos a factores de riesgo
     acumulados (menores en exclusión, absentistas, hijos de adictos).
   * Meta: Compensar desventajas y evitar el paso al consumo habitual.
------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN INDICADA:
   * Destinatarios: Individuos que YA han iniciado consumos experimentales
     o abusivos, o presentan signos iniciales de conducta adictiva sin
     cumplir aún criterios diagnósticos de dependencia establecida.
   * Meta: Detener la progresión hacia la adicción crónica.
========================================================================
```

5.2. Factores de Riesgo frente a Factores de Protección

La intervención socioeducativa opera mediante el balance sistemático entre variables de riesgo y de protección:

Ámbito	Factores de Riesgo	Factores de Protección
Individual	Baja tolerancia a frustración, impulsividad, búsqueda de sensaciones, locus de control externo, baja autoestima.	Asertividad, habilidades de toma de decisiones, inteligencia emocional, autoeficacia.
Familiar	Pautas parentales negligentes o autoritarias, consumo en el hogar, conflicto familiar crónico, falta de apego.	Parentalidad positiva, comunicación abierta, apego seguro, supervisión educativa coherente.
Escolar	Fracaso escolar, absentismo reiterado, rechazo de iguales, desenganche institucional.	Buen clima escolar, sentido de pertenencia, detección precoz de desajustes, éxito académico.
Comunitario	Alta accesibilidad y permisividad hacia las drogas, falta de equipamientos deportivos, estigmatización barrial.	Red asociativa activa, alternativas de ocio nocturno saludable, cohesión vecinal, normatividad contraria al consumo.

5.3. Ámbitos de Actuación Preventiva en Andalucía

1. **Ámbito Escolar / Educativo**:
2. Programas acreditados de la Junta de Andalucía integrados en el currículo: programa **Creciendo en Salud** (Educación Infantil y Primaria) y programa **Forma Joven en el Ámbito Educativo** (Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos), en el que los educadores sociales participan en asesorías de salud sobre drogas y afectividad.
3. **Ámbito Familiar**:

4. Escuelas de Familias y talleres de parentalidad positiva para progenitores, capacitando en habilidades de comunicación, detección precoz de señales de alerta y fijación de límites no violentos en el hogar.
5. **Ámbito Comunitario y Medio Abierto**:
6. Campañas de sensibilización callejera, programas de ocio nocturno alternativo libre de alcohol (deporte nocturno, talleres culturales en fines de semana) y cumplimiento estricto de las ordenanzas sobre terrazas, botellones y dispensación a menores.

---

6. Los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) y la Red Asistencial en Andalucía

La atención a las personas con problemas de adicciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía se articula a través de una red mixta socio-sanitaria, pública, integrada, de cobertura universal y acceso totalmente gratuito.

```
          ESTRUCTURA DE LA RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES EN ANDALUCÍA
=========================================================================
NIVEL DE PROXIMIDAD / PRIMARIO:
* Equipos de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y Centros de Salud (AP).
-------------------------------------------------------------------------
NIVEL AMBULATORIO ESPECIALIZADO:
* Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) (Núcleo asistencial territorial).
* Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) (Titularidad Diputación).
-------------------------------------------------------------------------
RECURSOS RESIDENCIALES Y DE SEGUNDO NIVEL:
* Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH) (Ingreso corto en SAS).
* Comunidades Terapéuticas (CT) (Tratamiento residencial intensivo).
* Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) y de Apoyo a la Reinserción (VAR).
-------------------------------------------------------------------------
RECURSOS DE APOYO Y REDUCCIÓN DE DAÑOS:
* Centros de Día (Apoyo a la deshabituación y formación sociolaboral).
* Centros de Encuentro y Acogida (CEA) (Comida, higiene, metadona, jeringuillas).
=========================================================================
```

6.1. Los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)

Los **Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)** son órganos técnicos especializados cuya titularidad y gestión administrativa corresponde a las **Diputaciones Provinciales** andaluzas (en la provincia de Sevilla, incardinado en el Área de Cohesión Social de la Diputación de Sevilla), actuando en estrecha coordinación y concierto financiero con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Sus funciones esenciales son: - Coordinación, supervisión y apoyo técnico a todos los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de su demarcación provincial. - Tramitación y gestión administrativa de las propuestas de derivación de usuarios hacia los recursos de segundo nivel (Comunidades Terapéuticas, Viviendas Tuteladas y Unidades de Desintoxicación). - Elaboración de los mapas epidemiológicos provinciales y recogida de indicadores del Sistema de Información del PADA (**SIPADA**). - Asesoramiento pericial y emisión de informes técnicos para órganos judiciales en supuestos de suspensión de penas (arts. 80.5 y 87 CP).

6.2. Los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)

Los **Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)** constituyen la puerta de acceso especializada y el eje vertebrador de toda la red asistencial: - Están integrados por **equipos interdisciplinares**: médicos/psiquiatras, psicólogos clínicos, educadores sociales y trabajadores sociales. - Prestan asistencia médica, psicológica y socioeducativa individualizada en régimen abierto. - Gestionan los **Programas de Mantenimiento con Agonistas Opiáceos (Metadona y Buprenorfina)** para la deshabituación o el mantenimiento crónico. - Diseñan y ejecutan el **Programa Individualizado de Tratamiento (PIT)**, coordinando el proceso de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción socioeducativa.

6.3. Recursos Residenciales y de Reducción del Daño

1. **Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)**:
2. Ubicadas en hospitales públicos del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SAS).
3. Ingresos de corta estancia (generalmente entre 7 y 21 días) bajo estricto control médico, indicados para desintoxicaciones de alta complejidad biológica (alcoholismo severo, benzodiacepinas, policonsumo) o fracasos ambulatorios reiterados.
4. **Comunidades Terapéuticas (CT)**:
5. Centros residenciales en régimen cerrado orientados a la deshabituación y rehabilitación psicológica intensiva. Dirigidos a personas que carecen de soporte sociofamiliar suficiente o precisan aislamiento temporal de su entorno habitual de consumo. La estancia media oscila entre 3 y 9 meses.
6. **Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT) y de Apoyo a la Reinserción (VAR)**:
7. Pisos tutelados normalizados en núcleos urbanos donde conviven usuarios en fases avanzadas de tratamiento, aprendiendo a gestionar la convivencia doméstica, rutinas y búsqueda de empleo con supervisión técnica periódica.
8. **Centros de Día**:
9. Dispositivos diurnos intermedios para la adquisición de hábitos sociales, habilidades para la vida y formación ocupacional.
10. **Centros de Encuentro y Acogida (CEA) y Dispositivos de Reducción del Daño**:
11. Orientados a consumidores activos de alta marginalidad y deterioro biológico que no desean o no pueden iniciar un proceso de abstinencia.
12. Suministran servicios de alimentación básica, higiene, curas, intercambio de material de inyección estéril (prevención de VIH y Hepatitis C), dispensación de metadona y salas de consumo higiénico.

---

7. La Intervención del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

En el municipio de Utrera, la intervención técnica ante el fenómeno de las drogas y adicciones se estructura de forma intersectorial y coordinada:

```
          CIRCUITO DE INTERVENCIÓN EN ADICCIONES EN UTRERA
=========================================================================
1. DETECCIÓN Y ATENCIÓN BÁSICA | Centro de Servicios Sociales Comunitarios
                               | (calle Catalina de Perea, 32).
-------------------------------------------------------------------------
2. TRATAMIENTO AMBULATORIO     | Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA)
                               | de Utrera (Equipo multidisciplinar).
-------------------------------------------------------------------------
3. PREVENCIÓN ESCOLAR Y EMAE   | Coordinación con IES de Utrera
                               | y seguimiento del absentismo escolar.
-------------------------------------------------------------------------
4. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA    | Barriada El Tinte (ERACIS+) y
                               | pedanías (Guadalema, Trajano y Pinzón).
-------------------------------------------------------------------------
5. INSERCIÓN SOCIOLABORAL      | Programa Arquímedes y formación local.
=========================================================================
```

1. **Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Utrera**:
2. Dispositivo especializado de referencia para Utrera y su comarca. El Educador/a Social forma parte del equipo técnico interdisciplinar, realizando valoraciones socioeducativas, tutorización individualizada en el marco del PIT, mediación familiar y seguimiento del cumplimiento de pautas terapéuticas y judiciales.
3. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:

4. Detección de familias vulnerables con miembros afectados por adicciones. Tramitación de recursos de apoyo social (Renta Mínima, IMV) y derivación coordinada hacia el CTA o el CPD de la Diputación de Sevilla.
5. **Prevención Escolar y Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**:
6. Coordinación técnica estrecha con los Institutos de Educación Secundaria del término municipal (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
7. Abordaje del consumo incipiente de cannabis y alcohol en adolescentes absentistas, impartiendo talleres de habilidades para la vida y desmitificación de las drogas dentro del programa *Forma Joven*.
8. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (Estrategia ERACIS+)**:
9. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado por el FSE+), despliegue de actuaciones en la **Barriada El Tinte** orientadas a la prevención comunitaria del policonsumo de sustancias y de la adicción a las **apuestas deportivas online y salones de juego**, protegiendo a los jóvenes en exclusión social.
10. **Descentralización Preventiva en las Pedanías Utreranas**:
11. Extensión de campañas preventivas e intervenciones socioeducativas individualizadas en **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, evitando que el aislamiento rural sea un factor de invisibilización de adicciones en jóvenes y mujeres.
12. **Inserción Sociolaboral: El Programa Arquímedes**:
13. El Educador Social canaliza a usuarios estabilizados en el CTA de Utrera hacia el **Programa Arquímedes** de la Junta de Andalucía, gestionando itinerarios personalizados de formación, prácticas y contratación en empresas para culminar su proceso de autonomía personal.

---

8. Secciones Pedagógicas de Cierre Obligatorias

A. Datos de Examen (25 Ítems de Memorización Clave)

1. **Definición de droga según la OMS**: Sustancia que altera el SNC, capaz de crear dependencia física, psicológica y tolerancia.
2. **Dependencia física vs. psíquica**: La física implica neuroadaptación somática y síndrome de abstinencia al cesar; la psíquica es el impulso y anhelo irrefrenable (*craving*).
3. **Tolerancia cruzada**: Fenómeno por el cual la tolerancia a una droga genera tolerancia hacia otra droga farmacológicamente afín (ej.: alcohol y benzodiacepinas).
4. **Neurobiología de la adicción**: Circuito mesocorticolímbico de recompensa: Área Tegmental Ventral (ATV) $ ightarrow$ Núcleo Accumbens (NAcc) $ ightarrow$ Corteza Prefrontal (CPF); mediado por la dopamina.
5. **Clasificación farmacológica del SNC (OMS)**: Depresoras (psicolépticos), Estimulantes (psicoanalépticos) y Perturbadoras/Alucinógenas (psicodislépticos).
6. **Ejemplos de drogas depresoras**: Alcohol, opiáceos (heroína, morfina, metadona), benzodiacepinas y disolventes volátiles.
7. **Ejemplos de drogas estimulantes mayores**: Cocaína (clorhidrato y crack) y anfetaminas (metanfetamina, speed).
8. **Ejemplos de drogas perturbadoras**: Cannabis (THC), LSD, psilocibina, MDMA (éxtasis) y ketamina.
9. **Ley 4/1997, de 9 de julio**: Ley matriz andaluza de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas; prohíbe venta de alcohol y tabaco a menores de 18 años.
10. **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**: Regula la acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias en Andalucía.

11. **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**: Regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (PADA).
12. **Adscripción orgánica del PADA**: Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía (Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica).
13. **Tres niveles preventivos de Robert Gordon (1987)**: Universal (toda la población), Selectiva (grupos de riesgo) e Indicada (usuarios que ya consumen sin dependencia).
14. **Artículo 36.16 de la Ley Orgánica 4/2015**: Tipifica como infracción grave el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares o transportes públicos.
15. **Suspensión de sanciones a menores en la LO 4/2015**: Posible si el menor se somete a actividades reeducativas o de tratamiento de deshabituación.
16. **Artículo 368 del Código Penal**: Distingue tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud (3 a 6 años de prisión) de las que no causan grave daño (1 a 3 años).
17. **Suspensión de penas por deshabituación (artículo 80.5 y 87 CP)**: Permite suspender penas de prisión de hasta 5 años a drogodependientes en tratamiento.
18. **Fondo de Bienes Decomisados (Ley 17/2003)**: Destina los bienes incautados al narcotráfico para financiar programas de prevención y asistencia.
19. **Titularidad de los Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD)**: Pertenecen y son gestionados por las **Diputaciones Provinciales**.
20. **Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA)**: Eje básico de la atención especializada interdisciplinar (médico, psicólogo, educador social, trabajador social).
21. **Unidades de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)**: Corta estancia hospitalaria (7-21 días) en centros del SAS para desintoxicaciones complejas.
22. **Comunidades Terapéuticas (CT)**: Recursos residenciales cerrados de media-larga estancia (3 a 9 meses) para deshabituación intensiva.
23. **Centros de Encuentro y Acogida (CEA)**: Recursos de baja exigencia orientados a la reducción de daños (higiene, alimentación, metadona, jeringuillas).
24. **Programa Arquímedes**: Programa oficial andaluz para la formación e inserción sociolaboral de personas con problemas de adicciones.
25. **Adicciones reconocidas en manuales clínicos**: Juego patológico (ludopatía en DSM-5) y Trastorno por uso de videojuegos (*Gaming Disorder* en CIE-11).

B. Esquema de Repaso Rápido

```
========================================================================
               CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA DEL SNC
========================================================================
* DEPRESORAS (Psicolépticos)  : Alcohol, Opiáceos (Heroína, Metadona),
                                Benzodiacepinas, Barbitúricos.
* ESTIMULANTES (Psicoanalépt.): Cocaína, Crack, Anfetaminas, Nicotina.
* PERTURBADORAS (Psicodislép.): Cannabis (THC), LSD, MDMA, Ketamina.
========================================================================
                    MARCO JURÍDICO CLAVE
========================================================================
* ESTATAL:
  - Ley 28/2005 y 42/2010 : Prohibición de fumar en espacios públicos cerrados.
  - LO 4/2015 Seguridad C. : Art. 36.16 (consumo/tenencia en vía pública = grave).
  - Código Penal           : Art. 368 (Grave daño vs. No grave daño) |
                             Art. 80.5 y 87 (Suspensión pena hasta 5 años).
  - Ley 17/2003            : Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico.
* ANDALUZ:
  - Ley 4/1997             : Ley matriz andaluza (Prohíbe alcohol/tabaco < 18a).
  - Decreto 273/2001       : Acreditación de centros de drogodependencias.
  - Decreto 70/2004        : Regulación del Plan Andaluz sobre Drogas (PADA).
========================================================================
               NIVELES DE PREVENCIÓN (GORDON / OMS)
========================================================================
* UNIVERSAL : Toda la comunidad/escuela (retrasar edad de inicio).
* SELECTIVA : Grupos en riesgo social (menores en exclusión, absentismo).
* INDICADA  : Individuos con consumos incipientes o daño inicial.
========================================================================
            RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES EN ANDALUCÍA
========================================================================
* PROXIMIDAD  : Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) y Centros de Salud.
* AMBULATORIO : Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) (Equipo nuclear) |
                Centros Provinciales de Drogodependencias (CPD) (Diputación).
* RESIDENCIAL : Unidades Desintoxicación Hospitalaria (UDH, 7-21 días, SAS) |
                Comunidades Terapéuticas (CT, 3-9 meses) |
                Viviendas de Apoyo al Tratamiento / Reinserción (VAT/VAR).
* DAÑO MENOR  : Centros de Encuentro y Acogida (CEA) y Centros de Día.
* EMPLEO      : Programa Arquímedes.
========================================================================
```

C. Trampas del Test (Confusiones Críticas Desarticuladas)

1. **Titularidad administrativa de los Centros Provinciales (CPD)**:
   Trampa: Afirmar que los Centros Provinciales de Drogodependencias dependen exclusivamente de los Ayuntamientos o directamente del SAS.
   Realidad: Los CPD son órganos técnicos gestionados y dependientes de las **Diputaciones Provinciales**, aunque se coordinan con la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.
2. **Adscripción de las competencias de drogas en Andalucía**:
   Trampa: Considerar que el PADA sigue perteneciendo a la Consejería de Inclusión Social o Asuntos Sociales.
   Realidad: En la estructura orgánica vigente, las competencias del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones están adscritas a la **Consejería de Salud y Consumo** (Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica).
3. **Clasificación del Cannabis en el SNC**:
   Trampa: Clasificar el cannabis como una droga depresora pura o estimulante.
   Realidad: El cannabis y sus derivados (hachís, marihuana) se clasifican formalmente como **drogas perturbadoras del SNC o psicodislépticos** debido a sus efectos en la alteración sensorial y distorsión perceptual.

4. **Suspensión de penas en el Código Penal**:
   Trampa: Creer que para beneficiarse de la suspensión de penas por drogodependencia del art. 80.5 CP la condena debe ser inferior a 2 años.
   Realidad: El límite general para no ingresar en prisión son 2 años; sin embargo, para reos drogodependientes que hayan cometido el delito a causa de su adicción y estén en tratamiento, el Código Penal eleva excepcionalmente el beneficio de suspensión **hasta penas de 5 años de prisión**.
5. **Niveles de Gordon: Selectiva vs. Indicada**:
   Trampa: Confundir la prevención selectiva con la indicada.
   Realidad: La **prevención selectiva** se dirige a grupos por pertenecer a entornos de riesgo (aunque aún no consuman); la **prevención indicada** se dirige a sujetos que **ya presentan consumos experimentales o señales iniciales de adicción**.
6. **Consumo de drogas en la vía pública en la LO 4/2015**:
   Trampa: Considerar que el consumo de cannabis en la vía pública constituye un delito penal.
   Realidad: El consumo o tenencia en lugares públicos para consumo propio **no es delito penal, sino infracción administrativa grave** (art. 36.16 de la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana), sancionable con multa económica que puede suspenderse en menores.
7. **Diferencia funcional entre UDH y Comunidad Terapéutica**:
   Trampa: Afirmar que en las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria se realizan tratamientos de rehabilitación de varios meses.
   Realidad: Las UDH son de **corta estancia (7 a 21 días)** para la retirada física supervisada de la sustancia (desintoxicación); la rehabilitación psicológica intensiva de meses (deshabituación) se realiza en las **Comunidades Terapéuticas (CT)**.

D. Enfoque Práctico en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

La operatividad del Tema 34 en la labor del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera se refleja en los siguientes recursos y programas municipales:

1. **Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Utrera**:
2. Dispositivo asistencial especializado donde el Educador Social realiza tutorías individuales, contratos de contingencia, seguimiento socioeducativo del Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) y apoyo a la reinserción social en coordinación con el CPD de la Diputación de Sevilla.
3. **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera (calle Catalina de Perea, 32)**:
4. Detección precoz de familias en las que confluye desestructuración por adicciones. Tramitación de prestaciones sociales y derivación hacia la red ambulatoria pública.
5. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) de Utrera**:
6. Coordinación técnica con institutos de secundaria (**IES Ruiz Gijón, IES Ponce de León, IES José María Infantes, IES Virgen de Consolación**).
7. Abordaje socioeducativo individualizado con menores absentistas que consumen hachís/marihuana o alcohol en horarios lectivos, aplicando intervenciones de prevención indicada y talleres de habilidades sociales.
8. **Intervención Comunitaria en la Barriada El Tinte (ERACIS+)**:
9. En el marco del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas de Utrera (financiado con FSE+), despliegue de acciones comunitarias en la **Barriada El Tinte** orientadas a la prevención del policonsumo de sustancias y el control de la proliferación de la ludopatía digital y apuestas online entre jóvenes vulnerables.
10. **Descentralización en las Pedanías Utreranas**:

11. Extensión de programas preventivos a las pedanías de **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**, acercando la información y recursos de asesoramiento a las familias del entorno rural.
12. **Inserción Sociolaboral: Programa Arquímedes**:
13. Gestión de itinerarios integrados de formación ocupacional y prácticas tuteladas para personas en fase de deshabituación del CTA de Utrera, promoviendo convenios con empresas del tejido productivo utrerano.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Convenio Único de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961**. *BOE nº 96, de 22/04/1966*.
- **Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971**. *BOE nº 218, de 10/09/1976*.
- **Ley 17/1967, de 8 de abril**, por la que se actualizan las normas sobre estupefacientes. *BOE nº 86, de 11/04/1967*.
- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre**, del Código Penal (arts. 368 a 378, 80.5 y 87). *BOE nº 281, de 24/11/1995*.
- **Ley 4/1997, de 9 de julio**, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de Andalucía. *BOJA nº 85, de 24/07/1997*.
- **Decreto 273/2001, de 18 de diciembre**, sobre acreditación de centros de atención a personas con problemas de drogodependencias en Andalucía. *BOJA nº 149, de 27/12/2001*.
- **Ley 17/2003, de 29 de mayo**, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas. *BOE nº 129, de 30/05/2003*.
- **Decreto 70/2004, de 24 de febrero**, por el que se regula el Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. *BOJA nº 43, de 03/03/2004*.
- **Ley 28/2005, de 26 de diciembre**, de medidas sanitarias frente al tabaquismo (modificada por Ley 42/2010). *BOE nº 309, de 27/12/2005*.
- **Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo**, de protección de la seguridad ciudadana (art. 36). *BOE nº 77, de 31/03/2015*.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía. *BOJA nº 8, de 13/01/2017*.
- **Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024**. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
- **Gordon, R. S.** (1987). An operational classification of disease prevention. *Public Health Reports*, 98(2), 107-109.
- **Kramer, J. F., & Cameron, D. C.** (1975). *A manual on drug dependence*. World Health Organization.
- **American Psychiatric Association (APA)**. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5)*.
- **World Health Organization (WHO)**. (2018). *International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision - CIE-11)*.